

Consent Information - Patient's Copy Cerebral Vasospasm Treatment

معلومات الإقرار - نسخة المريض علاج انقباض الأوعية الدموية في المخ

1. What is treatment for Cerebral Vasospasm?

Vasospasm is the sudden narrowing of a blood vessel which leads to a decrease of blood flow to the brain. If left untreated it can result in a stroke.

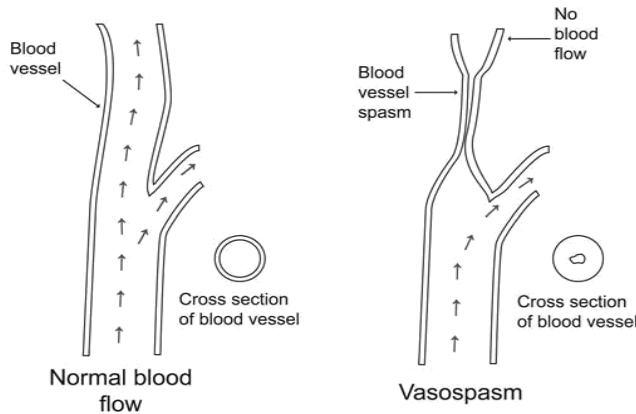
Treatment for cerebral vasospasm includes injecting medication directly into the narrowed blood vessels. This medication opens up the blood vessels.

Unfortunately, the effects of the medication are short lived and repeated cerebral injections may be required until the vasospasm settles.

Sometimes, a special balloon may be inflated into the narrowed blood vessel to help open it up and improve the blood flow.

Treatment is performed as an extra step to an angiogram procedure. An angiogram is a procedure where x- rays and Iodinated 'Contrast' (once called x-ray dye) is used to examine the blood flow in your brain and to locate the vessels that are in vasospasm.

An angiogram is done by placing a needle and a thin plastic tube (catheter) into the artery in your groin.



Vasospasm - Herston Multi Media Unit, RBWH, 2009

2. Will there be any discomfort, is any anesthetic needed?

This procedure will require an injection of local anesthetic and depending on the severity of the symptoms from the vasospasm a sedation or general anesthetic may be required. If you are booked for a general anesthetic you will be given a pre-anesthesia check up.

1. ما هو علاج انقباض الأوعية الدموية في المخ ؟

انقباض الأوعية الدموية هو تضيق مفاجئ للأوعية الدموية مما يسبب تقليل تدفق الدم إلى المخ . قد يسبب ذلك السكتة الدماغية إذا ترك دون علاج.

علاج انقباض الأوعية الدموية في المخ يشمل حقن مباشر للأدوية في الأوعية الدموية المتضيق . تقوم هذه الأدوية بفتح الأوعية الدموية.

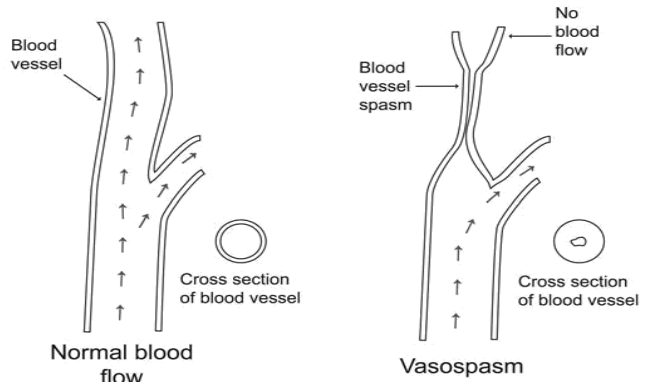
لسوء الحظ ، فإن مفعول هذه الأدوية قصير الأمد ، وقد تكون هناك حاجة لتكرار حقن المخ حتى استقرار انقباض الأوعية الدموية.

في بعض الأحيان ، قد يتم نفخ نوع معين من البالونات في الوعاء الدموي المتضيق للمساعدة على فتحه وبالتالي تحسين تدفق الدم.

العلاج يقدم كخطوة إضافية لإجراء تصوير الأوعية الدموية (التصوير الوعائي). هذا التصوير هو إجراء تستخدم فيه الأشعة السينية ومادة وسط متباين معالجة باليود (تسمى سابقاً صبغة الأشعة السينية) ويستخدم لمعرفة تدفق الدم في المخ ولتحديد الأوعية الدموية التي تعاني انقباضاً.

يجرى التصوير الوعائي بإدخال إبرة وأنبوب بلاستيكي رفيع (قسطرة) في الشريان بمنطقة أعلى الفخذ.

للمزيد من المعلومات عن مادة الوسط المتباين المعالجة باليود والمخاطر المتعلقة باستخدامها ، نرجو قراءة ورقة المعلومات المخصصة للمريض والمتعلقة بمادة الوسط المتباين المعالجة باليود. (إذا لم تكن هذه الورقة بحوزتك ، نرجو قيامك بطلبها).



Vasospasm - Herston Multi Media Unit, RBWH, 2009

2 هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟

سيطلب القيام بهذا الإجراء إعطائك حقنة مخدر موضعي . وبحسب شدة الأعراض الناتجة عن انقباض الأوعية الدموية فقد تكون هنا حاجة لإعطاء دواء مسكن أو تخدير كلي. إذا كنت ستجري الفحص تحت التخدير الكلي نرجو منك التوجه لقسم التخدير للفحص المسبق.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

3. What is sedation?

Sedation is the use of drugs that give you a 'sleepy-like' feeling. It makes you feel very relaxed during a procedure that may be otherwise unpleasant or painful. You may remember some or little about what has occurred during the procedure.

This procedure may only have a light sedation. You need to be able to fully co-operate at times by holding your breath when instructed by the doctor.

Sedation is generally very safe but has a risk with side effects and complications. Whilst these are usually temporary, some of them may cause long-term problems.

The risk to you will depend on:

- a) whether you have any other illness
- b) Personal factors, such as whether you smoke or are overweight.

4. Preparation for the procedure

The medical imaging department will give you instructions on how to prepare for your procedure.

- You will be told when to have your last meal and drink. This is to make sure your stomach is empty so that if you vomit during the procedure there will be nothing to go into your lungs.
- Please tell the staff if you are or suspect you might be pregnant or are breastfeeding.
- If you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin) or any other drug that is used to thin your blood ask your doctor/health practitioner if you should stop taking it before the procedure as it may affect your blood clotting.
- List or bring all your prescribed drugs, those drugs you buy over the counter, herbal remedies and supplements.
- Do not drink any alcohol and stop recreational drugs 24 hours before the procedure as these may alter the affects of the sedation anesthetic. If you have a drug habits please tell your doctor.

5. During the procedure

The Radiologist (x-ray doctor) will perform the angiogram. This involves the injection of local anesthetic into the skin. A needle and catheter are inserted into the artery in your groin; sometimes your arm may be used. Once the catheter is in place the needle is removed.

The catheter is guided through the main blood vessels in your body until it reaches the blood vessels that go to your brain.

X-ray pictures are taken while the contrast is injected into your arteries.

When the vessels that are in vasospasm have been located the medication will be slowly injected and/or the balloon will be inflated.

After the treatment, more contrast will be injected to allow the Radiologist to further assess the blood flow through your brain.

3. ماذا يعني التسكين (إعطاء دواء مسكن)؟

هو إعطاء دواء يعطيك شعور بالنوم ويجعلك مسترخ جداً خلال الإجراء ، حيث أن القيام بهذا الإجراء دون إعطاء مسكن قد يكون مزعج ومؤلم. قد تكون لديك القدرة لتذكر بعض مما حدث أثناء القيام بالإجراء.

في هذا الإجراء تعطى مسكن خفيف . من المهم أن تكون أن تكون قادراً على التجاوب التام مع الطبيب عندما يطلب منك حبس النفس.

الدواء المسكن بشكل عام آمن ، إلا أن له مخاطره وآثاره الجانبية و مضاعفاته ، وعلى الرغم أن غالبيتها تكون مؤقتة ، إلا أن البعض منها قد تكون له مشاكل طويلة الأمد.

المخاطر بالنسبة لك تتوقف على:

- إذا كنت مصاب بأمراض أخرى .
- عوامل شخصية مثل التدخين أو زيادة الوزن.

4. التحضير للإجراء

سيقوم قسم الأشعة والتصوير الطبي بإعطائك تعليمات متعلقة بالتحضير لهذا الإجراء.

- سيتم إبلاغك بأخر موعد يمكنك فيه تناول الطعام والشراب قبل إجراء الفحص ، والهدف من ذلك هو التأكد من خلو المعدة أثناء الفحص من أي أكل أو شراب ، لمنع وصول أي منها إلى الرئة في حالة حدوث تقيؤ أثناء الفحص.
- نرجو إبلاغ العاملين إن كنت حاملاً أو تشكين في كونك حاملاً ، أو كنت تمارسين الرضاعة الطبيعية.
- إذا كنت ممن يتناولون أدوية الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايبيريدامول (بيرسانتين أو اساسانتين) ، أو أي دواء آخر يسبب سيولة في الدم ، فاسأل طبيبك عما إذا كان ينبغي عليك إيقاف استخدامها قبل الإجراء لأن هذه الأدوية تتداخل مع تخثر الدم.
- احضر معك كل الأدوية الموصوفة لك ، والأدوية التي تبتاعها دون وصفة ، والعلاجات العشبية والعلاجات التكميلية ، أو احضر قائمة بها.
- لا تحتسي الكحوليات وأوقف تعاطي كل الأدوية والعقاقير الترفيهية التي تتناولها ، وذلك قبل 24 ساعة من الإجراء ، لأنها قد تؤثر على مفعول دواء التخدير المسكن. إذا كنت معتاداً على عقاقير أو أدوية بعينها ، فابلق الطبيب بذلك.

5. خلال الإجراء

يقوم طبيب الأشعة بإجراء التصوير الوعائي ، ويستدعي ذلك حقن مخدر موضعي في الجلد . يتم إدخال إبرة وقسطرة رفيعة في الشريان بمنطقة أعلى الفخذ ، في بعض الأحيان قد تستخدم الذراع. تزال الإبرة بعد إدخال القسطرة إلى موقعها المحدد.

تمرر القسطرة داخل الأوعية الدموية الرئيسية في الجسم حتى تصل إلى الوعاء الدموي الذي يذهب إلى المخ.

تؤخذ صور بالأشعة السينية بينما يتم حقن مادة الوسط المتباين في الشرايين.

بعد أن يتم تحديد موقع الأوعية الدموية التي تعاني انقباضاً ، يتم ببطين حقن الدواء وأو يتم نفخ البالون.

بعد العلاج ، يتم حقن المزيد من مادة الوسط المتباين لتمكين طبيب الأشعة من

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

When the procedure is finished the catheter will be removed. Firm pressure will be put over the area where the catheter went into your skin (puncture site), sometimes a special plug is used. This allows the artery to seal over so you will not bleed.

If repeated treatments are likely, the catheter will be removed but a small tube (sheath) may be left in place to allow future access to the artery.

6. After the procedure

You will be monitored in the hospital's Intensive Care Unit (ICU). You will need to lie flat and keep your leg (or arm) still and straight for 4 to 6 hours. Moving too soon after the procedure may cause bleeding at the puncture site. If the sheath was left in then you will need to lie flat and keep your leg (or arm) still and straight for as long as it is in place.

7. What are the risks of this specific procedure?

The risks and complications with this procedure and with having a device inserted can include but are not limited to the following.

Rare risks and complications of the medication used include:

- Low blood pressure, which may require treatment with medications.
- Build up of pressure in the fluid around the brain requiring medication and/or a temporary drain to be inserted.

Common risks and complications of the actual procedure include:

- Minor pain, bruising and/or infection from the IV cannula. This may require treatment with antibiotics.
- Pain or discomfort at the puncture site. This may require medication.
- Bleeding or bruising may occur. This is usually stopped by applying pressure and/or ice to the puncture site. This is more common if you take Aspirin, Warfarin, Clopidogrel (Plavix and Iscover) or Dipyridamole (Persantin and Asasantin).
- Failure of local anesthetic which may require a further injection of anesthetic or a different method of anesthesia may be used.
- Nerve damage, is usually temporary, and should get better over a period of time. Permanent nerve damage is rare.

Less common risks and complications of the actual procedure include:

- Infection, requiring antibiotics and further treatment.
- Damage to surrounding structures such as blood vessels, organs and muscles, requiring further treatment.
- Stroke from blood clots or damage to the artery, the blocking off of normal blood vessels in the brain. This can cause weakness in the face, arms and legs. This could be temporary or permanent.

إجراء التقييم اللازم لتدفق الدم داخل المخ.
بعد انتهاء الإجراء ، تتم إزالة القسطرة ، ومن ثم وضع ضغط قوي على الجلد في منطقة دخول القسطرة أو وضع سدادة مخصصة ، يؤدي ذلك إلى إحكام إغلاق الشريان لمنع حدوث نزيف من منطقة إدخال القسطرة.

إذا كان من المرجح تلقي المريض للدواء بشكل متكرر ، فإنه وبعد إزالة القسطرة ، قد يتم ترك أنبوب صغير (مثل الجيب) للسماح بالدخول المتكرر إلى الشريان.

6. بعد انتهاء الإجراء

ستتم مراقبتك في المستشفى في وحدة العناية المركزة.
سيطلب منك الاستلقاء مسطحاً على ظهرك مع إبقاء ساقك (أو ذراعك) ممدودة وفي حالة سكون (ثبات) لمدة 4-6 ساعات. التسرع في الحركة بعد الإجراء قد يسبب نزيف من موضع إدخال القسطرة. إذا كان لديك الأنبوب الصغير (مثل الجيب) فإنك ستكون مضطراً لأن تظل مسطحاً على ظهرك مع إبقاء ساقك (أو ذراعك) ممدودة وفي حالة سكون (ثبات) طوال فترة بقاءه.

7. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

المخاطر و المضاعفات المرتبطة بهذا الإجراء وبوجود جهاز داخل الجسم تشمل ، ولكنها غير محصورة في :

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث للدواء المستخدم ، وتشمل:

- انخفاض في ضغط الدم مما قد يتطلب العلاج بأدوية.
- ارتفاع الضغط في السوائل حول المخ مما يتطلب إعطاء أدوية وأو إدخال أنبوب تصريف مؤقت.

مخاطر ومضاعفات شائعة للإجراء الفعلي ، وتشمل:

- ألم بسيط ، كدمة و/أو عدوى عند منطقة دخول الإبرة الوريدية . قد يتطلب المعالجة بمضادات حيوية.
- ألم أو الشعور بعدم الراحة في منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك المعالجة بالأدوية.
- حدوث نزيف أو كدمة . يتوقف ذلك عادة بوضع ضغط و/أو ثلج على موضع دخول القسطرة . يحدث ذلك بشكل أكثر شيوعاً عند من يتناولون أدوية الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دابايردامول (بيرسانتين أو اساسانتين) .
- فشل في عمل المخدر الموضعي مما قد يتطلب إعطاء حقنة أخرى منه ، أو استخدام أسلوب تخدير آخر.
- ضرر لعصب . عادةً ما يكون ذلك مؤقتاً ، ومن المفترض تحسنه مع الوقت . من النادر حدوث ضرر دائم للعصب.

مخاطر ومضاعفات أقل شيوعاً للإجراء الفعلي ، وتشمل:

- عدوى تتطلب مضادات حيوية وعلاجات أخرى.
- ضرر للأنسجة المحيطة كالأوعية الدموية ، الأعضاء الأخرى والعضلات وتتطلب معالجات أخرى.
- سكتة دماغية بسبب تخثر دموي أو ضرر يصيب الشريان مسبباً انسداد الأوعية الدموية الطبيعية في المخ . قد يسبب ذلك ضعف في الوجه ، الذراعين والساقين. قد يكون ذلك بشكل مؤقت أو دائم.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Failure of the treatment to improve the vasospasm or it may increase the severity of the already present vasospasm.
- A blood clot or excessive bleeding from the puncture site. This may require other treatment and/or corrective surgery.
- An allergy to injected drugs, requiring further treatment.
- The procedure may not be possible due to medical and/or technical reasons.

Rare risks and complications of the actual procedure include:

- Rupture of a blood vessel during balloon inflation requiring other treatment and/or corrective surgery.
- An increased lifetime cancer risk due to the exposure to x-rays.
- Skin burns or damage from exposure to x-rays.
- Seizures and/or cardiac arrest due to local anaesthetic toxicity.
- Death as a result of this procedure is very rare.

Risks of Iodinated Contrast for patients with renal impairment:

There is a specific risk of giving Iodinated Contrast Media to patient's identified as having *Renal Impairment*. Giving the Contrast to people with weakened kidneys (renal impairment) can cause further kidney damage, which may in turn cause the kidneys to stop working properly (acute renal failure).

If sedation is given extra risks include:

- Faintness or dizziness, especially when you start to move around
- Fall in blood pressure
- Nausea and vomiting
- Weakness
- An existing medical condition getting worse
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia. This may require emergency treatment

Notes to talk to my doctor/health practitioner about:

- فشل الدواء في تحسين انقباض الأوعية الدموية ، أو تسببه في تفاقم الانقباض الموجود.
- خثرة دموية أو نزيف مفرط من منطقة دخول القسطرة . قد يتطلب ذلك معالجات أخرى و/أو جراحة تصحيحية.
- رد فعل تحسسي لأي من الأدوية المعطاة . يتطلب ذلك علاجات أخرى.
- قد لا يكون القيام بالإجراء ممكناً لأسباب طبية و / أو فنية (تقنية).

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث للإجراء الفعلي ، وتشمل:

- تمزق في وعاء دموي أثناء نفخ البالون . قد يتطلب ذلك معالجات أخرى و/أو جراحة تصحيحية.
- زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان خلال حياة المريض بسبب التعرض للأشعة السينية.
- حروق أو ضرر يصيب الجلد بسبب التعرض للأشعة السينية.
- تشنجات و/أو سكتة قلبية بسبب سمية المادة المستخدمة في التخدير الموضعي.
- الوفاة نادرة جداً كسبب لهذا الإجراء.

د . مخاطر مادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.
المخاطر المحددة لمادة الوسط المتباين المعالجة باليود عند المرضى المصابين باعتلال عمل الكلى.
إعطاء مادة الوسط المتباين لمرضى يعانون من ضعف عمل الكلى قد يسبب أضراراً إضافية للكلى ، مما قد يسبب توقف الكلى عند العمل بشكل صحيح (فشل كلوي حاد).

مخاطر إضافية في حالة استخدام دواء التخدير المسكن ، وتشمل:

- إغماءة أو دوخة ، خاصة عند البدء في الحركة بعد نهاية الإجراء.
- انخفاض في ضغط الدم .
- غثيان ، وتقيؤ .
- شعور بالضعف.
- تفاقم أي مرض آخر يعاني منه المريض.
- مشاكل في القلب والرئة كالأزمة القلبية أو دخول المادة المتبقية إلى الرئة مسببة التهاباً رئوياً. قد يتطلب ذلك تدخل علاجي طارئ.

أمر أقوم بمناقشتها مع طبيبي المعالج
